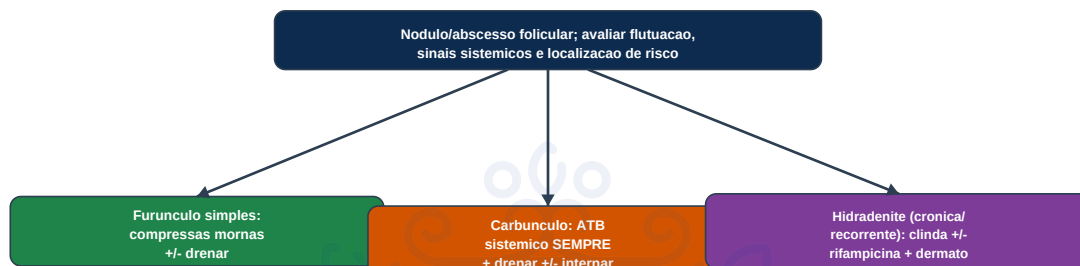


FURÚNCULO / CARBÚNCULO / HIDRADENITE

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

NÓDULO/ABSCESSO -> DRENAR + ATB SE INDICADO



AS TRÊS ENTIDADES

Entidade	Características
Furúnculo	Infecção profunda do folículo (S. aureus 90%): nódulo eritematoso doloroso 1-5 cm com pústula central e drenagem
Carbúnculo	Confluência de furúnculos: massa > 5 cm, múltiplos pontos de drenagem ('crivo'), endureção; maior risco de bacteremia/sistêmico
Hidradenite supurativa (HS)	Doença inflamatória CRÔNICA recorrente das glândulas apócrinas (axilas, virilha, anogenital): nódulos, abscessos, FÍSTULAS, cicatrizes; NÃO é furúnculo recorrente
HS — Hurley	I: nódulos/abscessos sem fístulas; II: + fístulas e cicatrizes; III: túneis interconectados, fibrose difusa

RED FLAGS / LOCALIZAÇÕES DE RISCO

NÃO PERDER

- FACE (triângulo nasolabial): risco de trombose do seio cavernoso (cefaleia intensa, proptose, oftalmoplegia)
- PERÍNEO/genital: risco de gangrena de Fournier (edema, crepitação, necrose, odor fétido, toxemia)
- Fasceíte necrotizante: dor desproporcional, progressão rápida, crepitação, bolhas hemorrágicas, necrose
- SEPSE: febre/hipotermia, taquicardia, hipotensão, alteração mental
- Carbúnculo é sempre potencialmente grave; imunossuprimido/diabético descompensado tem maior risco

TRATAMENTO — FURÚNCULO E CARBÚNCULO

Rx DRENAR + ATB QUANDO INDICADO

FURÚNCULO simples: compressas mornas 3-4x/dia (favorece drenagem); higiene antisséptica; NUNCA espremer/manipular; analgesia (Dipirona)

DRENAGEM cirúrgica se: flutuação (abscesso maduro), > 5 cm, dor intensa, sem melhora em 48h

ATB sistêmico (se celulite perilesional > 2 cm, múltiplas lesões, face, febre/sistêmico, imunossupressão/DM, impossibilidade de drenar): Cefalexina 500 mg 6/6h ou Amox-clav 875/125 12/12h por 7 dias

Suspeita de MRSA/alérgico: SMX-TMP 800/160 12/12h, ou Doxiciclina 100 mg 12/12h, ou Clindamicina 300-450 mg 8/8h por 7-10 dias

CARBÚNCULO: ATB sistêmico SEMPRE + drenagem se flutuação; internar se febre alta/toxemia/face/imunossupressão/DM descompensado; Oxacilina 2 g EV 4/4h ou Cefazolina (Vancomicina se MRSA); 10-14 dias

Sempre coletar CULTURA do material drenado no carbúnculo/recorrência

TRATAMENTO — HIDRADENITE E FURUNCULOSE RECORRENTE

Rx ABORDAGEM ESPECÍFICA

HS agudo (abscesso flutuante): incisão e drenagem simples (evitar excisão ampla na fase aguda)

HS Hurley I (leve): Clindamicina 300 mg 8/8h por 10-14 dias (boa penetração nas glândulas apócrinas)

HS Hurley II-III/refratário: Clindamicina 300 mg 8/8h + Rifampicina 300 mg 12/12h por 10 semanas (ou Doxiciclina + Rifampicina); encaminhar à DERMATOLOGIA (biológicos — adalimumabe; antiandrogênicos; cirurgia definitiva)

HS — medidas fundamentais: PARAR DE FUMAR (essencial), perda de peso, roupas folgadas, antissépticos, evitar depilação com lâmina

FURUNCULOSE recorrente: descolonização de *S. aureus* — Mupirocina nasal 2x/dia + banho com clorexidina 4% por 5 dias; repetir mensalmente por 3-6 meses; ATB supressivo (clindamicina 150 mg/dia por 3 meses) se falha

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: carbúnculo com sinais sistêmicos/sepsis; localização facial (triângulo); suspeita de fascíte/Fournier (EMERGÊNCIA); celulite extensa/infangite progressiva; imunossupressão grave; DM descompensado (glicemia > 300); falha ambulatorial; dor não controlada (HS grave); drenagem em centro cirúrgico
- ☐ ALTA: afebril 24-48h, lesão drenada se indicado, melhora clínica, sem celulite progressiva, tolerando ATB VO, glicemia controlada, seguimento garantido
- ☐ Cuidados: completar o ATB; curativos 1-2x/dia; compressas mornas se ainda endurecido; NÃO espremer/furar em casa; higiene rigorosa
- ☐ Alarme: febre alta, vermelhidão em expansão/listras, dor crescente, bolhas/necrose, confusão, lesão facial piorando (cefaleia/diplopia), sem melhora em 48-72h
- ☐ HS: encaminhar à dermatologia (tratamento de longo prazo); recorrente: investigar DM/imunossupressão/MRSA

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com ____ (furúnculo/carbúnculo/HS) em ____ há ____ dias; flutuação ____, drenagem ____, celulite perilesional ____ cm.
- Gravidade: febre ____, toxemia/sepsse ____, face/Fournier/fasceíte ____; comorbidade (DM HGT ____, imunossupressão).
- Conduta: drenagem ____, ATB ____ iniciado às ____, analgesia, controle glicêmico; cultura ____.
- Solicito internação enfermaria/UTI / drenagem em CC; complicação: ____.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

O que diferencia o carbúnculo do furúnculo?

- A) O carbúnculo é mais superficial e indolor
- B) O carbúnculo é a confluência de vários furúnculos, com múltiplos pontos de drenagem ('crivo') e maior risco sistêmico
- C) São sinônimos
- D) O furúnculo atinge osso
- E) O carbúnculo não tem agente bacteriano

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual conduta é fundamental no furúnculo simples flutuante?

- A) Espremer a lesão em casa
- B) Drenagem (incisão) quando há flutuação, com compressas mornas; ATB só se indicado
- C) Antibiótico EV de rotina
- D) Corticoide sistêmico
- E) Excisão ampla imediata

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que a hidradenite supurativa NÃO deve ser tratada apenas como 'furúnculo recorrente'?

- A) Porque é uma infecção simples
- B) Porque é doença inflamatória crônica das glândulas apócrinas, com fístulas/cicatrizes, exigindo abordagem específica (clindamicina ± rifampicina, dermatologia)
- C) Porque não tem tratamento
- D) Porque é contagiosa
- E) Porque sempre exige cirurgia imediata

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que o furúnculo do triângulo nasolabial (face) é uma localização de risco?

- A) Risco de osteomielite
- B) Risco de trombose do seio cavernoso
- C) Risco de pancreatite
- D) Risco de hérnia
- E) Não tem risco

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é a medida não farmacológica MAIS importante no manejo da hidradenite supurativa?

- A) Aumentar a fricção local
- B) Cessar o tabagismo (e perda de peso)
- C) Depilar com lâmina
- D) Usar roupas justas
- E) Banhos quentes prolongados

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O carbúnculo é a confluência de vários furúnculos adjacentes, formando massa maior com múltiplos pontos de drenagem ('crivo') e maior risco de bacteremia/complicações sistêmicas — exige ATB sistêmico sempre.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No furúnculo simples flutuante, a drenagem (incisão) é fundamental, com compressas mornas; o antibiótico é reservado a celulite, face, sinais sistêmicos, imunossupressão ou impossibilidade de drenar. Nunca espremer.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A HS é doença inflamatória crônica das glândulas apócrinas, com fístulas e cicatrizes, e demanda abordagem específica (clindamicina ± rifampicina, medidas gerais e dermatologia), não apenas drenagem de 'furúnculo'.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O furúnculo do triângulo nasolabial tem risco de trombose do seio cavernoso pela drenagem venosa da face, exigindo cuidado e ATB.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A cessação do tabagismo (associada à perda de peso) é a medida não farmacológica mais importante na hidradenite supurativa, reduzindo os surtos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico